

Реконструкция мочеточника

Информация для пациента · Операция по восстановлению заблокированного или суженного мочеточника

WARWIKI

Реконструкция мочеточника — это операция по восстановлению заблокированного или суженного мочеточника (трубки, по которой моча поступает из почки в мочевой пузырь) для восстановления нормального оттока и защиты почки. Метод зависит от расположения и протяжённости сужения: используются собственные концы мочеточника, тканевой трансплантат или фрагмент кишечника.

Об этой процедуре

Стриктура (рубцовое сужение) мочеточника задерживает мочу и создаёт нагрузку на почку. Метод восстановления подбирается индивидуально:

- **Короткое сужение** — поражённый участок удаляют и сшивают здоровые концы, либо мочеточник повторно подсоединяют к мочевому пузырю (иногда пузырь подтягивают вверх).
- **Более длинное сужение** — мочеточник расширяют с помощью **трансплантата**, обычно небольшого фрагмента слизистой щеки (для этого есть отдельный листок).
- **Обширное или тяжёлое поражение** — для замещения мочеточника используют участок собственного **кишечника**.

Для поддержания просвета во время заживления устанавливают мягкий внутренний **стент**. Операцию, как правило, выполняют **роботически или лапароскопически** (через небольшие проколы), реже открытым способом. Результаты лечения хорошие.

Это безопасно?

Это проверенные и эффективные операции; метод подбирается с учётом вашей анатомии. Как при любом серьёзном вмешательстве, возможны риски: кровотечение, инфекция или временное подтекание мочи (обычно контролируется стентом и дренажом). Рецидив сужения возникает редко. При использовании кишечника кишечнику требуется несколько дней на восстановление, и в моче может появиться небольшое количество слизи.

ТЕРМИНЫ

Мочеточник

Трубка, по которой моча поступает из почки в мочевой пузырь.

Стриктура

Рубцовое сужение, замедляющее или блокирующее ток мочи.

Уретеральный стент

Мягкая внутренняя трубка («double-J»), удерживающая просвет открытым во время заживления.

Трансплантат (графт)

Небольшой лоскут собственной ткани, чаще слизистой щеки, для расширения мочеточника.

Сегмент кишечника

Участок собственного кишечника для замещения длинного дефекта.

Реимплантация

Повторное подсоединение мочеточника к мочевому пузырю.

Гидронефроз

Расширение почки из-за застоя мочи выше блокады.

Роботически / лапароскопически

Операция через небольшие проколы без большого разреза.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей анестезией — во время неё вы ничего не чувствуете. После ожидайте болезненность в области разрезов; внутренний стент может вызывать позывы или лёгкую боль в боку. При использовании кишечника кишечнику требуется несколько дней на «пробуждение». Большинство пациентов остаётся в стационаре 1–3 дня; продолжительность операции зависит от вида вмешательства.

Как подготовиться (До операции)

- Операция под **общей анестезией** — соблюдайте все предоперационные инструкции (голодание, какие препараты отменить, включая антикоагулянты).
- **Анализ мочи** проверяет наличие инфекции — её необходимо пролечить до операции.
- **Не курите** — курение замедляет заживление. При возможном использовании кишечника может потребоваться подготовка кишечника; при использовании трансплантата щеки — уход за полостью рта.
- Планируйте **стент примерно на 4–6 недель** и организуйте сопровождение домой.

Сообщите лечащей команде заранее, если вы:

- Принимаете **антикоагулянты** или имеете активную инфекцию
- Перенесли операции на животе или малом тазу, или лучевую терапию

Что происходит во время операции

- 1 Вы спите под анестезией; вводятся антибиотики.
- 2 Хирург делает небольшие проколы или разрез и получает доступ к суженному участку.
- 3 Мочеточник восстанавливают — сшивают концы, расширяют трансплантатом или замещают сегментом кишечника — поверх стента.
- 4 При необходимости оставляют небольшой дренаж; разрезы ушивают.

После операции

- Обычно выписывают через **1–3 дня**.
- **Стент остаётся внутри около 4–6 недель**, затем удаляется в ходе короткой офисной цистоскопии.
- Симптомы стента (позывы, лёгкая боль в боку, розоватая моча) — **норма**. При использовании кишечника питайтесь легко; **избегайте нагрузок** несколько недель.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Сильная или нарастающая боль в боку или животе
- Обильное кровотечение или невозможность помочиться
- Упорная рвота или отсутствие газов и стула (при использовании кишечника)
- Нарастающее покраснение, боль или выделения из раны

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Реконструкция мочеточника восстанавливает проходимость и защищает почку. Метод подбирается индивидуально: сшивание концов, трансплантат щеки или сегмент кишечника — поверх внутреннего стента.
2. Для подготовки: соблюдайте голодание и инструкции по препаратам, пролечите инфекцию, не курите, планируйте стент на 4–6 недель и организуйте сопровождение.
3. Стент может вызывать позывы до его удаления в кабинете врача — это нормально.